



บทบาท Nurse Coordinator

กับการปลูกถ่ายอวัยวะ

พว.พีร่า ปานพรม

พยาบาลประสานงาน โรงพยาบาลศิริราช

การปลูกถ่ายอวัยวะ

การนำเอาอวัยวะที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติออกไปแล้ว
นำเอาอวัยวะปกติจากบุคคลอื่นเข้ามาแทน ในปัจจุบันสามารถกระทำได้
กับอวัยวะหลายส่วนแต่ที่ได้ผลดี และนิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ การ
ปลูกถ่ายไต ตับ ไชกระดุก หัวใจ ปอด หัวใจและปอด ลำไส้ และตับอ่อน
การปลูกถ่ายอวัยวะนี้มักจะกระทำหลังจากที่แพทย์ไม่สามารถรักษาได้
ด้วยวิธีอื่นแล้ว เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นวิธีการที่ทำได้ยาก

บริจาค อวัยวะ

อุทิศ ร่างกาย



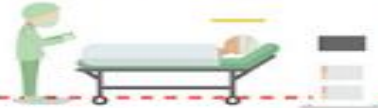
นำอวัยวะ ไปปลูกถ่าย
ให้ผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆ
เสื่อมสภาพ



เสียชีวิตจาก
สมองตาย
เท่านั้น



หลังผ่าตัด
แพทย์ตกแต่งร่างกายให้เรียบร้อย
มอบให้ญาติไปประกอบพิธี



รับแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะจาก
ทั่วประเทศ



แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะที่
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
หรือสำนักงานจังหวัดทุกแห่ง, โรงพยาบาลประจำจังหวัด
หรือ โทร 1666, www.organdonate.in.th

อุทิศร่างกาย
ให้นักศึกษาแพทย์ศึกษา



เสียชีวิตจากสาเหตุ
ธรรมชาติ
อวัยวะครบ



หลังจากการเสียชีวิต
ต้องแจ้งให้ไปปรับร่าง
ภายใน 24 ชม.
หลังการศึกษา 2 ปี
จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลให้



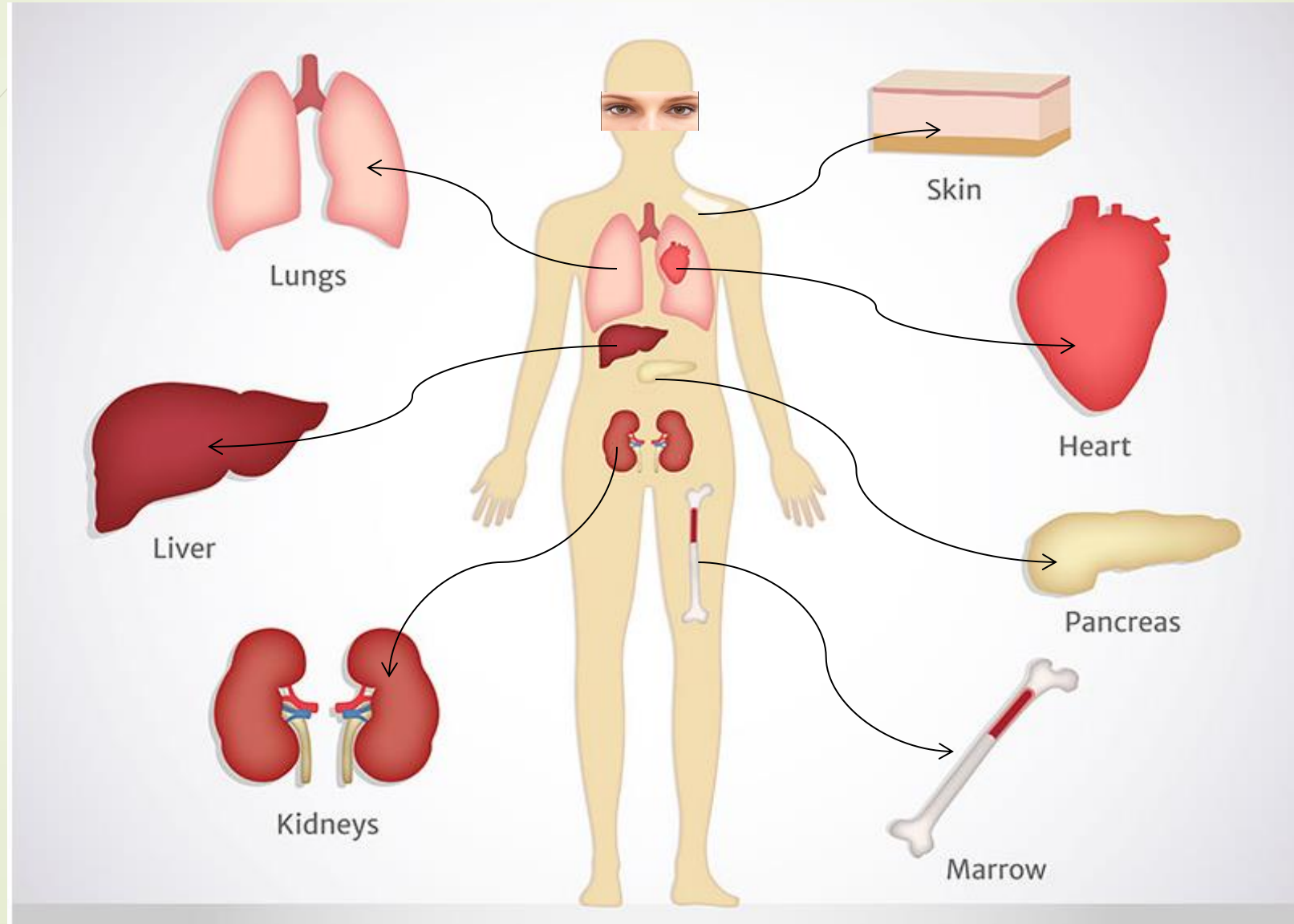
แต่ละสถาบันมีเกณฑ์
การรับอุทิศร่างกายต่างกัน



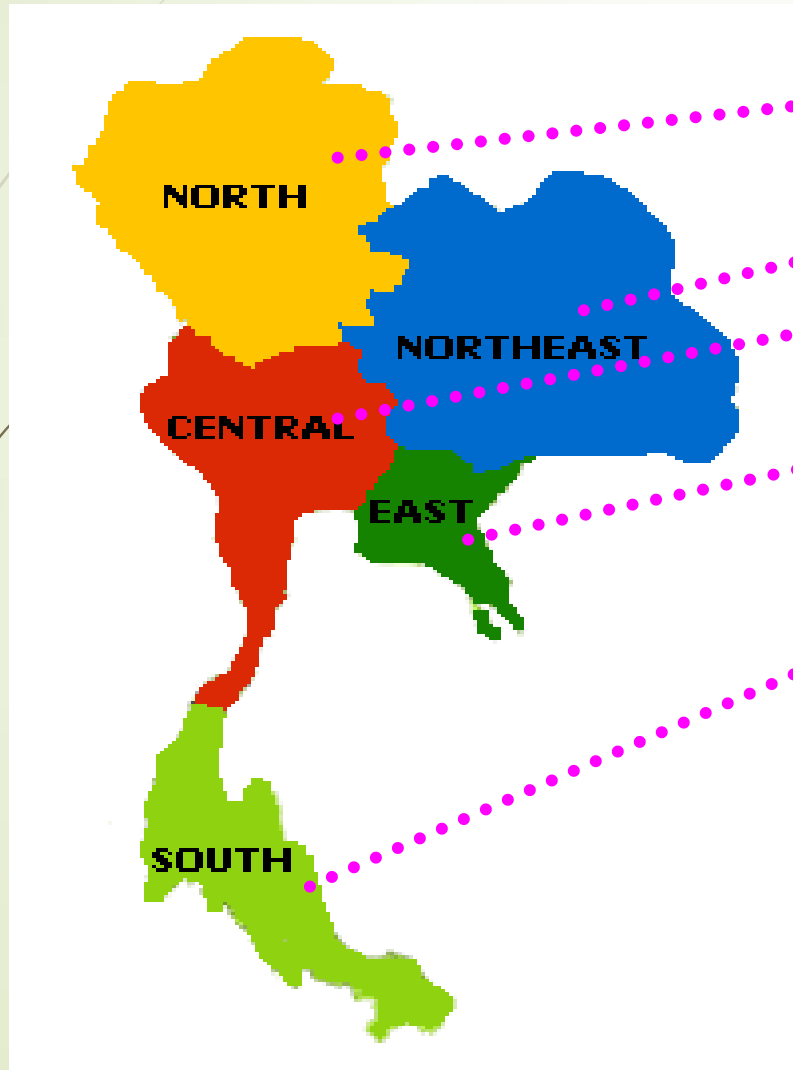
ติดต่อได้ที่
คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง

การบริจาคอวัยวะ และ อุทิศร่างกาย สามารถติดต่อ
แสดงความจำนงได้ทั้ง 2 ประเภท และเมื่อถึงเวลานับจริง
จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามความเห็นของแพทย์และหลักวิชาการ

บริจาค...อะไรได้น้าง



ผู้บริจาคมาจากแหล่งใดบ้าง

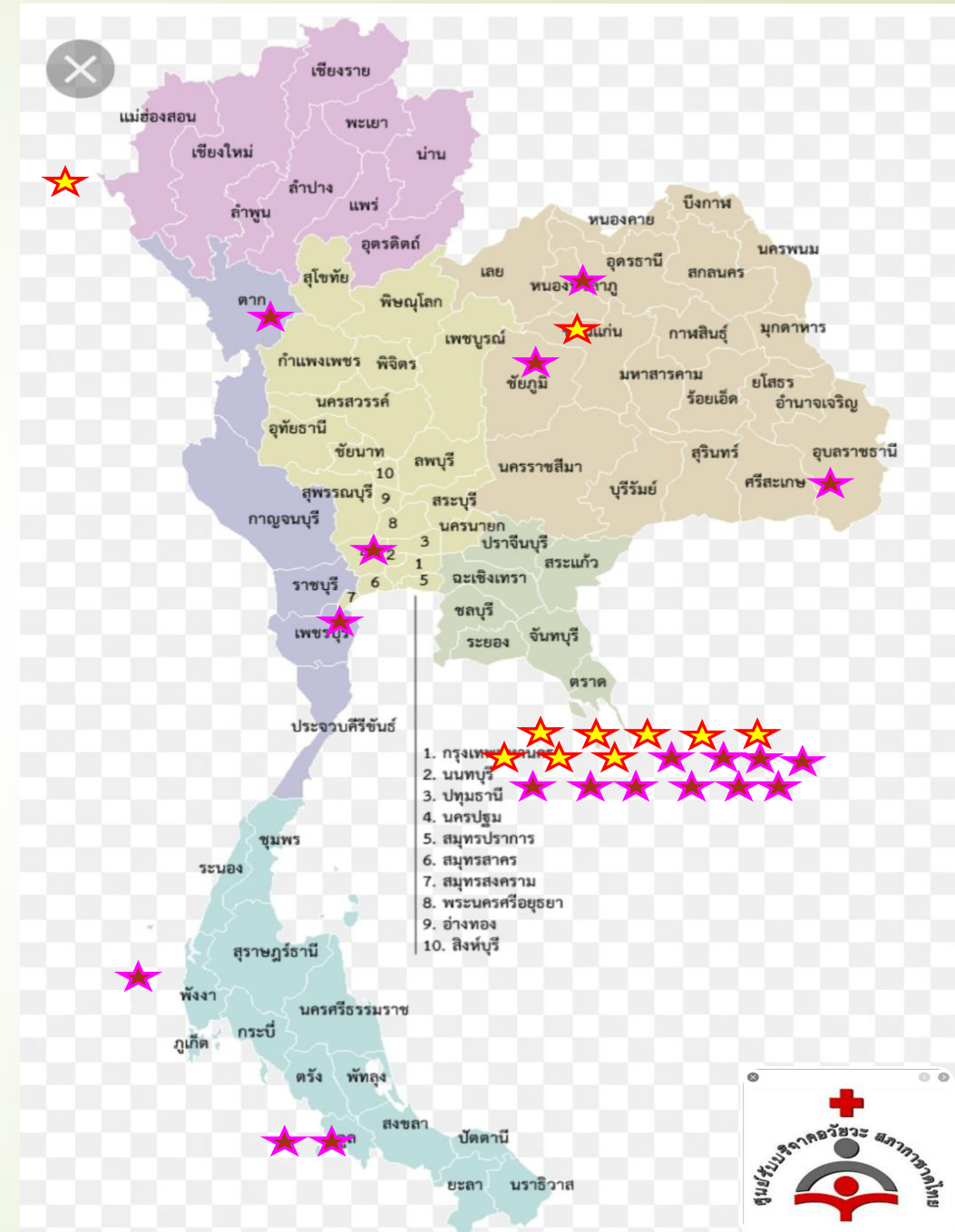


Organ Donation Center
The Thai Red Cross Society

- Waiting list registration
- Organ allocation

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายไต
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 - 31 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาล	เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
1. จุฬาลงกรณ์	1 กุมภาพันธ์ 2537
2. ศิริราช	1 กุมภาพันธ์ 2537
3. รามาธิบดี	1 กุมภาพันธ์ 2537
4. พระมงกุฎเกล้า	1 กุมภาพันธ์ 2537
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1 กุมภาพันธ์ 2537
6. ศรีนครินทร์	1 กุมภาพันธ์ 2537
7. สงขลานครินทร์	1 กุมภาพันธ์ 2537
8. ศิริราช	30 สิงหาคม 2538
9. ภูมิพลอดุลยเดช	11 กรกฎาคม 2540
10. ราชวิถี	29 กรกฎาคม 2540
11. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*	29 กรกฎาคม 2540
12. สมิติเวช สุขุมวิท*	29 กรกฎาคม 2540
13. กรุงเทพ*	29 กรกฎาคม 2540
14. พระรามเก้า*	29 กรกฎาคม 2540
15. พญาไท 1*	29 กรกฎาคม 2540
16. วชิรพยาบาล	12 ตุลาคม 2541
17. ไทนครินทร์*	20 พฤศจิกายน 2543
18. ชลบุรี	20 ธันวาคม 2543
19. สรรพสิทธิประสงค์	9 เมษายน 2546
20. สมิติเวช ศรีนครินทร์*	19 พฤษภาคม 2547
21. พญาไท 2*	25 มกราคม 2549
22. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	7 พฤศจิกายน 2550
23. สุราษฎร์ธานี	18 มกราคม 2555
24. หาดใหญ่	16 กรกฎาคม 2557
25. ขอนแก่น	29 เมษายน 2558
26. อุตรธานี	29 เมษายน 2558
27. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์	15 สิงหาคม 2561
28. พุทธชินราช พิษณุโลก	3 เมษายน 2562
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ	29 มกราคม 2563
30. เชียงรายประชานุเคราะห์	25 พฤศจิกายน 2563
31. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25 พฤศจิกายน 2563
32. รามคำแหง*	23 มิถุนายน 2564





*โทร 1666



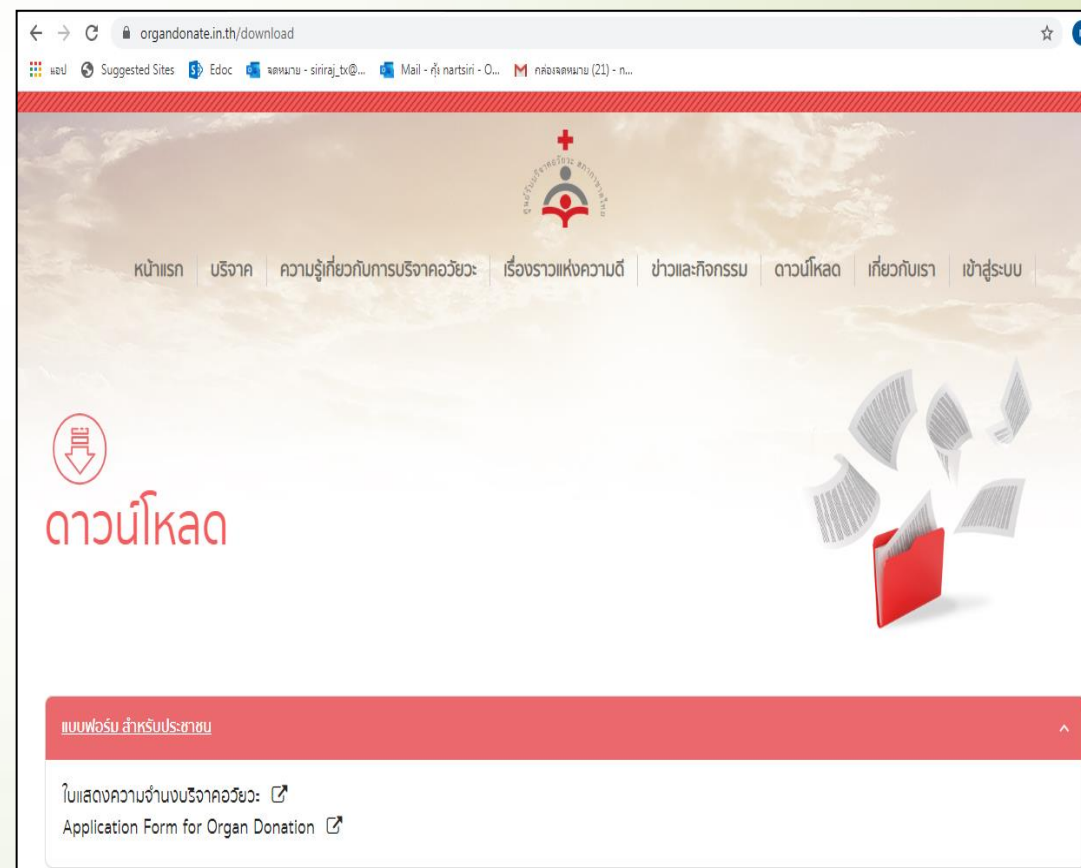
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

อาคารเกิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 1666 หรือ 0 2256 4045-6 โทรสาร 0 2255 7968

อีเมล: odc-trcs@redcross.or.th

สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.พระรามที่ 4 : สาย 4, 25 (ปากน้ำ-สามแยก), 46, 47, 50, 67, 109, ปอ.507
สายรถเมล์ที่ผ่าน ถ.อังรีดูนังต์ : สาย 16, 21, ปอ.21, ปอ.141



ผู้บริจาคสมองต่าย

(ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย)



กระบวนการรับบริจาคอวัยวะ



ผู้ป่วย

- ประเมินผู้ป่วย
- ประวัติการรักษา
- ร่วมปรึกษากับทีมที่ดูแล
- วางแผนกระบวนการบริจาคร่วมกับทีมผู้รักษา



ญาติ

- ให้ข้อมูลญาติ
- ขอบริจาคอวัยวะ
- ลงนามบริจาคอวัยวะ
- ดูแลญาติตลอดกระบวนการ



ทีมดูแลผู้บริจาค

- ดูแลผู้บริจาคจนกว่าจะส่งเข้า OR
- ประเมินสมองตาย 2 ครั้ง ห่างกัน 6 ชม
- ส่งแปลเพิ่มเติมตามที่ กาชาดกำหนด หรือ รพ.อื่นๆร้องขอ



ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

- แจ้งข้อมูลผู้บริจาค
- จัดสรรอวัยวะ
- จัดสรรทีมผ่าตัด
- ดูแลการเดินทางของทีมผ่าตัด
- จัดสรรผู้รับบริจาคอวัยวะ



ทีมผ่าตัด

- ผ่าตัดนำอวัยวะออก
- รายงานผลการผ่าตัดและบันทึก
- นำส่งอวัยวะ

ใบยินยอมของญาติผู้บริจาคอวัยวะ

เขียนที่ _____
วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.00 น.

ข้าพเจ้า ชื่อ _____ เลขประจำตัวประชาชน _____
ที่อยู่ บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ ถนน _____
ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____
โทรศัพท์ _____ มีความสัมพันธ์เป็น _____
ของผู้เสียชีวิตชื่อ _____ อายุ 20 ปี
เลขประจำตัวประชาชน _____ มีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะต่าง ๆ
ของผู้เสียชีวิต ดังต่อไปนี้ โดยไม่รับค่าตอบแทน

- ☐ หัวใจ ☐ ตับ ☐ ไต ☐ ปอด
☐ เนื้อเยื่อ ได้แก่ ☐ สิวหนัง ☐ กระดูก ☐ _____
☒ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้เป็นประโยชน์ได้

เพื่อให้แพทย์นำไปใช้รักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่น หรือใช้เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ หรือค้นคว้าวิจัยอื่นๆ ต่อไป

ลงชื่อ _____ ผู้อนุญาต
(_____)
ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)
ความสัมพันธ์ _____
ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)
ความสัมพันธ์ _____

บันทึกเพิ่มเติม กรณีญาติที่มีอำนาจลงนามยังไม่ได้รับอนุญาต

“ อิต - มนต์ อิมภพ บัณฑิตวิทยา ”

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ข้อมูล/ผู้บันทึก
ตำแหน่ง พยานคลินิก โรงพยาบาล _____

บันทึกการตรวจวินิจฉัยสมองตาย

ชื่อนามสกุล อายุ ปี เดือน

โรงพยาบาล HN

แพทย์ผู้ดูแล

คณะแพทย์ผู้วินิจฉัยสมองตาย

1.

2.

3.

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน

ครั้งที่ 1 วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.

ครั้งที่ 2 วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.

(ระยะเวลาระหว่างการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ป่วยทารกอายุระหว่าง 7 วัน ถึง 2 เดือน ต้องไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หากอายุระหว่าง 2 เดือนถึง 1 ปี ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)

โปรดใช้เครื่องหมาย ✓ ในขั้นตอนที่ตรวจ

1. สภาวะก่อนการวินิจฉัยสมองตาย

1.1 โรค หรือภาวะที่ทำให้สมองตาย

1.2 ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ และอยู่ในเครื่องช่วยหายใจ

ตั้งแต่ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.

1.3 ภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้หรือไม่

1.3.1 พิษยา (intoxication)

ยาเสพติด ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือ
สารพิษที่ทำให้กล้ามเนื้อไม่ทำงาน

1.3.2 ภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำรุนแรง (<32°C)

1.3.3 ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิก

(endocrine and metabolic disturbances)

1.3.4 ภาวะช็อก (shock)

1.3.5 สาเหตุอื่น ๆ ที่มีหนทางเยียวยาได้อีก

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ไม่ ไม่

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ไม่ ไม่

2. การตรวจและทดสอบเพื่อยืนยันสภาวะสมองตาย (tests for brain death)

2.1 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้หรือไม่

2.1.1 การเคลื่อนไหวได้เอง

[] []

2.1.2 อาการชัก

[] []

2.2 มีรีเฟล็กซ์ของก้านสมองดังนี้หรือไม่

2.2.1 รีเฟล็กซ์ของรูม่านตาต่อแสง(pupillary light reflex)

[] []

2.2.2 รีเฟล็กซ์ของกระจกตา(corneal reflex)

[] []

2.2.3 การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตา

[] []

(motor response within the cranial nerve distribution)

2.2.4 เวสติบูลออคูลาร์รีเฟล็กซ์(vestibulo-ocular reflex)

[] []

2.2.5 ออกคูโลเซฟาลิกรีเฟล็กซ์(oculoccephalic reflex)

[] []

2.2.6 รีเฟล็กซ์ของการกลืนและการไอ(gag and cough reflexes)

[] []

2.3 ทดสอบการไม่หายใจเป็นบวก โดยหยุดเครื่องช่วยหายใจนาน นาที(ไม่น้อยกว่า 10 นาที)

ตรวจค่า PaCO₂ ก่อนหยุดเครื่องช่วยหายใจเท่ากับ มิลลิเมตรปรอทเมื่อเวลา น.(เวลาที่ส่งตรวจ)

ตรวจค่า PaCO₂ หลังหยุดเครื่องช่วยหายใจเท่ากับ มิลลิเมตรปรอทเมื่อเวลา น.(เวลาที่ส่งตรวจ)

2.4 กรณีไม่สามารถทดสอบการไม่หายใจตามข้อ2.3ได้ มีการตรวจทดสอบยืนยันว่าไม่มีเลือด

ไหลเวียนเข้าสู่สมองโดยวิธีดังนี้เช่น [] cerebral angiogram [] Isotope brain scan หรือ []

2.5 ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองกรณีผู้ป่วยอายุไม่เกิน 1 ปีและไม่สามารถตรวจตามข้อ 2.4 ได้พบว่า

ขอรับรองว่าคณะแพทย์ได้ตรวจผู้ป่วยตามรายการและวัน เวลาดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าได้เกิด
สภาวะสมองตาย (brain death) ในผู้ป่วยรายนี้และแพทย์ได้ออกหนังสือรับรองการตายแล้ว

(1) ลงนาม (2) ลงนาม

(.....) (.....)

ตำแหน่ง ตำแหน่ง

(3) ลงนาม

(.....)

ตำแหน่ง

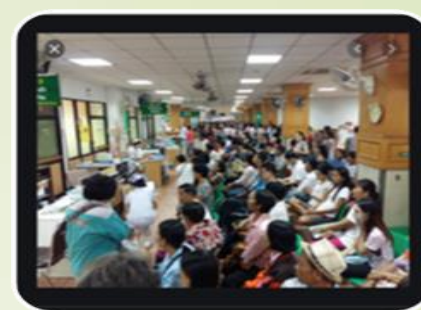
ผู้รับรองการวินิจฉัยสมองตาย และรับรองการตาย

ลงนาม

(.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมาย

การดูแลญาติผู้บริจาคอวัยวะ



ใบยินยอมของญาติผู้บริจาคอวัยวะ

ชื่อผู้บริจาค: [redacted] น. 126 72 80

แพทย์ผู้ดูแล: [redacted]

คณะกรรมการผู้บริจาคอวัยวะ

1. พญ. จันทิมาพร ขวัญใจ

2. พญ. รุจิรา ศรีจันทร์

3. พญ. พาริษา อภิโชค

วันเดือนปี ที่ประเมิน

ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.55 น.

(ระยะเวลาระหว่างการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ป่วยที่ตรวจระหว่าง 7 วัน ถึง 2 เดือน ต้องไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หากตรวจระหว่าง 2 เดือนถึง 1 ปี ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)

โปรดใช้เครื่องหมาย ✓ ในขั้นตอนที่ตรวจ

1. สภาพก่อนการวินิจฉัยสมองตาย

1.1 โรค หรือภาวะที่ทำให้สมองตาย ได้ตรวจแล้วหรือยัง

1.2 ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ และอยู่ในเครื่องช่วยหายใจ ตั้งแต่ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.25 น.

1.3 ภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้หรือไม่

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
	ไม่	ไม่
1.3.1 พิษยา (intoxication)	✓	✓
สาเหตุพิษ ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือสารพิษที่ทำให้กล้ามเนื้อไม่ทำงาน		
1.3.2 ภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำรุนแรง (<32°C)	✓	✓
1.3.3 ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ และเผาผลาญ (endocrine and metabolic disturbances)	✓	✓
1.3.4 ภาวะช็อก (shock)	✓	✓
1.3.5 สาเหตุอื่น ๆ ที่มีหนทางเยียวยาได้อีก	✓	✓

2. การตรวจและทดสอบเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองตาย (tests for brain death)

2.1 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้หรือไม่

2.1.1 การเคลื่อนไหวโดยบังเอิญ

2.1.2 อาการชัก

2.2 มีรีเฟล็กซ์ของกล้ามเนื้อหรือไม่

2.2.1 รีเฟล็กซ์ของรูม่านตาต่อแสง (pupillary light reflex)

2.2.2 รีเฟล็กซ์ของกระจกตา (corneal reflex)

2.2.3 การเคลื่อนไหวของอัมมิกซ์ในหน้าและลูกตา (motor response within the cranial nerve distribution)

2.2.4 เวสติบูลาร์-ออคูลาร์ รีเฟล็กซ์ (vestibulo-ocular reflex)

2.2.5 ออคูลูโกลาเรียรีเฟล็กซ์ (oculocephalic reflex)

2.2.6 รีเฟล็กซ์ของการกลืนและการไอ (gag and cough reflexes)

2.3 ทดสอบการไม่หายใจเป็นบวก โดยทดสอบเครื่องช่วยหายใจนาน 15 นาที (ไม่น้อยกว่า 10 นาที) ตรวจค่า PaCO₂ ก่อนทดสอบเครื่องช่วยหายใจเท่ากับ 66.4 มิลลิเมตรปรอทเมื่อเวลา 16.55 น. (เวลาที่ส่งตรวจ) ตรวจค่า PaCO₂ หลังทดสอบเครื่องช่วยหายใจเท่ากับ 66.4 มิลลิเมตรปรอทเมื่อเวลา 16.55 น. (เวลาที่ส่งตรวจ)

2.4 กรณีไม่สามารถทดสอบการไม่หายใจตามข้อ 2.3 ได้ มีผลการทดสอบอื่นที่สนับสนุนว่ามีสมองตายหรือไม่

2.5 ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองกรณีผู้ป่วยอายุไม่เกิน 1 ปี และไม่สามารถตรวจตามข้อ 2.4 ได้ด้วยว่า

ขอรับรองว่าคณะแพทย์ได้ตรวจผู้ป่วยตามรายการและวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าได้เกิดภาวะสมองตาย (brain death) ในผู้ป่วยรายนี้ และแพทย์ได้ออกใบนี้เพื่อรับรองการตัดสินใจ

(1) ชื่อ นาม พญ. พาริษา อภิโชค (2) ชื่อ นาม พญ. รุจิรา ศรีจันทร์

(3) ชื่อ นาม พญ. จันทิมาพร ขวัญใจ

ตำแหน่ง ผอ. โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้รับรองการวินิจฉัยสมองตาย และรับรองการเอา

นางสาว วิภา ภิรมย์

นางสาว วิภา ภิรมย์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ใบยินยอมของญาติผู้บริจาคอวัยวะ

ชื่อผู้บริจาค: [redacted]

เขียนที่ [redacted]

วันที่ [redacted]

เวลา [redacted]

แพทย์ผู้ดูแล: [redacted]

เลขประจำตัวประชาชน: [redacted]

ที่อยู่: [redacted]

ความสัมพันธ์: [redacted]

ขอผู้เสียชีวิต คือ [redacted] อายุ 20 ปี

เลขประจำตัวประชาชน: [redacted]

มีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะต่าง ๆ ของผู้เสียชีวิต ดังต่อไปนี้ โดยไม่รับค่าตอบแทน

☐ หัวใจ ☐ ตับ ☐ ไต ☐ ปอด

☐ เยื่อหุ้มหัวใจ ☐ ตับอ่อน ☐ กระเพาะอาหาร ☐ ลำไส้เล็ก

ไม่ขอบริจาคอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายที่ใช้เป็นประโยชน์ได้

เพื่อให้แพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยชีวิตอื่น หรือใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์ หรือค้นคว้าวิจัยอื่น ๆ ต่อไป

ลงชื่อ [redacted] ผู้บริจาค

ลงชื่อ [redacted] พยาน

ความสัมพันธ์ [redacted]

ความสัมพันธ์ [redacted]

บันทึกเพิ่มเติม กรณีญาติที่มีอำนาจของนามอำนาจไม่ให้เป็นผู้ลงนาม

ชื่อ นาม พญ. จันทิมาพร ขวัญใจ

ลงชื่อ [redacted]

ตำแหน่ง [redacted]

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมาย

การดูแลผู้ป่วยวิกฤต



ประวัติการรักษา

- อดีต: DM, HT, CA ฯลฯ, ปัจจุบัน: Dx, Tx, OR, CT ฯลฯ

ยา

- ยารักษาโรคเดิม, ยารักษาปัจจุบัน

สารน้ำ

- IV fluid, Oral Fluid

Hemodynamics

- V/S, O2 sat, CVP, Urine Out ทุก 1 ชม, I/O ทุก 8 hr 24 ชม

หมู่เลือด

- A, B, O, AB และ Rh-, Rh+

ส่วนประกอบของเลือด

- FFP, PRC ฯลฯ

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- CBC, Electrolyte, LFT, BUN, Cr, ,BS, HbA1C, UA, ABG, MUC, H/C, Sputum C/S ฯลฯ

ATB

- ชนิด, ขนาดที่ได้รับต่อวัน, เริ่ม - หยุด

Infectious marker (รพ.donor/RC)

- HIV, Hep B (HBsAg, Anti-HBc, Anti-HBs), Heb C, VDRL, CMV ฯลฯ

การตรวจทางรังสี

- Chest X ray, US, CT, Fast ฯลฯ

การตรวจอื่นๆ

- ECG, Echo, Apnea test+ABG *2 ครั้ง (ก่อน และหลังหยุดเครื่องช่วยหายใจ)

กระบวนการรับบริจาคอวัยวะ



การจัดสรรอวัยวะ



เรียน TC ทุกท่าน

มี Donor ร.พ. พหลพลพยุหเสนา ร.พ. ร้อยเอ็ด อายุ 21 ปี Gr. B+

ญาติบริจาคทุกอวัยวะ

ส่งตัวอย่างเลือดมาภาษาต ถึงสายใต้ 20.00 น. น่าจะถึง Lab ประมาณ 21.00น.

ถ้าทราบ ผล Prelim inf. ออกจะแจ้งอีกที ค่ะ

วินิจฉัยสมองตายครั้งที่ 1 วันที่ 19/12/2560 เวลา 13.00 น.

ครั้งที่ 2 Plan ทำเวลา 21.30 น.

การจัดสรร

คิวหัวใจ หัวใจปอด

urgent

1. จุฬา ฯ H-L Gr. B+
2. ศิริราช H-L Gr.O+
3. ศิริราช Heart Gr.O
4. ศิริราช Heart Gr.AB
5. จุฬา ฯ Heart Gr.O

คิวปกติ

- 1.บำรุงราษฎร์ NO active
- 2.ราม่า No WL
- 3.ราชวิถี
- 4.ศิริราช
- 5.จุฬา ฯ

คิวตับส่วนกลาง

- 1.ราชวิถี
- 2.ราม่า
- 3.เอกชน No B active
- 4.ศิริราช
- 5.จุฬา ฯ

คิวไตส่วนกลาง

- 1.ศิริราช
- 2.ภูมิพลอดุลยเดช
- 3.จุฬาลงกรณ์
- 4.สมิติเวช สุขุมวิท
- 5.สมิติเวช ศรีนครินทร์
- 6.วชิรพยาบาล งด 28 ธ.ค.-2 ม.ค.60
- 7.พญาไท 1
- 8.ธรรมศาสตร์
- 9.ราม่าธิบดี
- 10.กรุงเทพ
- 11.พระมงกุฎเกล้า
- 12.ราชวิถี
- 13.บำรุงราษฎร์
- 14.ตำรวจ
- 15.พระรามเก้า

การเดินทาง

โดยรถยนต์ รพ. RT ใช้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจราจรค่ะ
ขอบคุณค่ะ

การจัดสรรวัคซีน

ge.png | ดาวน์โหลด | เพิ่มหน้าจอ | พิมพ์ | บันทึกไปยัง OneDrive | แสดงอีเมล

✈ Depart Bangkok (Don Mueang) to Roi Et

		Sun 17 Dec 0.00	Mon 18 Dec 0.00	Tue 19 Dec 1,499.00	Wed 20 Dec 1,299.00	Thu 21 Dec 1,299.00
Departure	Arrival	Flight Information		Nok Lite ✈	Nok X-tra ✈	
05:40	→ 06:45	✈	1h 5m DD9114 Q400	1,499.00 2 seats left	1,799.00 2 seats left	
19:30	→ 20:55	✈	1h 25m DD9118 ATR72-500	1,699.00 2 seats left	1,998.99 2 seats left	

ไปกลับแบบปิด

✈ Return Roi Et to Bangkok (Don Mueang)

		Sun 17 Dec 0.00	Mon 18 Dec 0.00	Tue 19 Dec 1,099.00	Wed 20 Dec 1,099.00	Thu 21 Dec 1,099.00
Departure	Arrival	Flight Information		Nok Lite ✈	Nok X-tra ✈	
07:15	→ 08:15	✈	1h DD9115 Q400	1,099.00 1 seat left	1,398.99 1 seat left	
21:25	→ 22:45	✈	1h 20m DD9119 ATR72-500	1,299.00 4 seats left	1,599.00 4 seats left	



ชื่อ-สกุล..... Group AB เข้า ร.พ. มหาวิทยาลัยธรรมราช วันที่ 25 ธ.ค.61 เวลา 14.31 น.
ประวัติการเจ็บป่วย 2 hr PTA (07.30 น.) เจ็บหน้าอก หลัง บริเวณระดับทรวงอก 2 ข้าง เจ็บเกร็งๆ แบบปวดเมื่อย ร้าวไปที่ไหล่ 2 ข้าง
ไม่มีร้าวไปที่กราม มีเหงื่อแตก ไม่ใจสัน โปรพ.สูง 111, น. BP 170/111 mmHg, PR 98/min ให้ Isosorbide Dinitrate 1 tab SL แล้ว
refer DTX = 401 mg%, Ac Abdomen : No subdiaphragmatic free air, no gall stone

ระหว่าง admit เข้าห้องน้ำ อาเจียนอากรอ่อนแรงซีกซ้าย ต้มอง จากนั้นไม่พูด อ่อนแรงซีกซ้าย ปากเบี้ยวลิ้นซ้าย คมของด้านขวา
ผล CT วันที่ 29 ธ.ค.61 : Rt. MCA Infarction 1.3 cm midline shift, right uncal herniation, obstructive hydrocephalus.

การวินิจฉัยโรค Rt. MCA Infarction

การผ่าตัด วันที่ เวลา น.

ผลการผ่าตัด Finding

การวินิจฉัยสมองฉาย - ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธ.ค.61 เวลา 18.30 น.
- ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.61 เวลา 00.55 น.

☒ ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด P-CMV วันที่ 29 ธ.ค.61 เวลา 12.30 น. FiO2 1.0 TV Rate 16

☒ ไม่มี Cardiac arrest ☐ มี cardiac arrest วันที่ เวลา นาน

การรักษา

☐ ไม่มี Hypotension ☒ มี Hypotension BP mmHg วันที่ 29 ธ.ค.61 เวลา 08.00 น.นาน

☒ ได้ ☐ ไม่ได้ Inotropic drugs Lexyphed (1:25) 30 ml/hr, Dopamine (2:1) 30 ml/hr วันที่ 29 ธ.ค.61 เวลา 10.00

ยาและโดสที่ได้รับในการรักษาครั้งนี้

Antibiotics Clindamycin 600 mg OD, Cef-3 2 gm OD

ผลิตภัณฑ์จากเลือด

อื่นๆ

ประวัติอื่นๆ

การผ่าตัด ☒ ไม่เคย ☐ เคยผ่าตัด เมื่อ

เคยมีประวัติเป็น ☐ วัณโรค ☐ หัวใจ ☐ ความดันโลหิตสูง ☐ โรคไต ☐ เบาหวาน ☐ มะเร็ง ☒ ไม่มีโรคเหล่านี้

โรคประจำตัว Gout การรักษา ☒ สม่าเสมอ ☐ ไม่สม่าเสมอ

ยาที่กินประจำ ไม่ต้องรับประทานยา Gout แล้ว

การใช้ยาเสพติด ☐ ไม่มี ☐ มี ประเภท ระยะเวลา ความถี่ ปริมาณ / ครั้ง

กินเหล้าเบียร์ ☐ ไม่มี ☒ มี ระยะเวลา 1 ปี ความถี่ 4 ครั้ง/สัปดาห์ ปริมาณ / ครั้ง 2 ขวด

สูบบุหรี่ ☐ ไม่มี ☒ มี ระยะเวลา 20 ปี ความถี่ ทุกวัน ปริมาณ / ครั้ง 5 มวน/วัน

Donor หรือคู่ของ Donor มีบุคลิกภาพ / พฤติกรรมเสี่ยงหรือเบี่ยงเบนทางเพศ ☒ ไม่มี ☐ มี

เจาะหูสัก ลบรอยสัก สิวเข็ม สิวมุก ☒ ไม่มี ☐ มี ขนาด / ลักษณะ

เคยมีประวัติเพิ่งฟันไทย/จำตุก ☒ ไม่มี ☐ มี

เข้าไปในพื้นที่ที่มีเชื้อมาเลเรียชุกชุมในระยะ 1 ปี หรือป่วยเป็นมาเลเรียในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ☒ ไม่มี ☐ มี

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปฏิเสธ ประวัติโรคติดต่ออื่นๆ ปฏิเสธ

ประวัติอื่นที่สำคัญ

ประวัติเกี่ยวกับพิษสุรา ☒ ไม่เคยถูกสุราขัดขวาง 1 ปี ที่ผ่านมา

น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 168 ซม. รอบอก 92 ซม. รอบท้อง 81 ซม.



ชื่อ-สกุล น. Blood Group AB โรงพยาบาล ... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราช ...

วันที่/เวลา	BT	BP	PR	RR	CVP	Urine	Dopa (:)	Levoph (:)	Adren (:)	IV fluid /Note
25 ธ.ค.61										
09.50	36.5	153/99	65	20						ที่ ER
10.10		131/75	96	20						
14.00	36.5	131/102		20						
18.00	37.5	122/74		20						
22.00	37	130/50		20						
26 ธ.ค.61										
02.00	37	140/		20						
06.00	36.2	130/80		20						
10.00	37.2	140/80		20						
14.00	37	130/70		20						
18.00	37.3	154/80		20						
22.00	37.2	131/80		20						
27 ธ.ค.61										
02.00		131/74		24						
06.00	37	127/78		18						
09.00		134/77	90							E4V1M5 สี่ CT , on O2 cannula 3 LPM
10.00		108/64	90							E1V1M1
10.30		128/74	72							On ET tube
10.45		155/78	140							
11.00		133/87	100	24						
12.00		142/88	95	24						
13.00		153/87	84	24						
14.00	37.8	133/89	103	22						
17.00		129/78	86	22						
18.00	37.9	146/70	72	24						
19.00		145/87	102	24						

วันที่	เวลา/เวลา	Intake	Output
26/12/61		1,965	1,100
27/12/61		2,250	1,800
28/12/61		3,256	2,250
29/12/61	เช้า	3,180	3,700
	บ่าย	1,587	1,270
	คืน	1,986	715

วันที่	เวลา/เวลา	Intake	Output



ตรวจที่ วันที่/เวลา	FW.donor 29/12/61	HLA Lab 29/12/61	CBC วันที่ เวลา	25/12/61	26/12/61	29/12/61	29/12/61	29/12/61	30/12/61
HIV Ab		Neg	Hb	11.09	22.17	06.34	12.15	19.02	04.06
HIV Ag		Neg	Hct	15.8	15.6	14.7	14.0	14.0	15.4
HBs Ag	Neg	Neg	WBC	47.7	47.5	45.5	42	43.1	47.5
HBcAb	Neg	Neg	RBC	14,400	15,500	14,600	21,100	16,900	5,600
HBs Ab			Platelet	5.18	5.09	4.64	4.50	4.60	5.02
HCV Ab	Neg	Neg	Neutrophile	227,000	195,000	172,000	171,000	136,000	137,000
Syphilis	Non-react	Neg	Lymphocyte	87	77	87	79	75	74
CMV-IgG		+pos 106.2	Monocyte	9	15	6	13	16	20
CMV-IgM		Neg	Eosinophile	3	7	7	7	9	3
HBe Ag			Basophile	1	1	0	1	-	3
HBcAb			MCV	0	0	0	0	-	-
NAT (HIV, HCV, HCV)		Neg	MCH	92.2		94.0		93.8	94.6
			MCHC	30.5		30.5		30.5	30.7
				33.1		32.4		32.6	32.5

UA วันที่ เวลา	25/12/61	29/12/61	30/12/61	วันที่ เวลา	อื่นๆ วันที่ เวลา
pH	17.38	12.51	04.10	FiO ₂	
Sp. gr.	5.0	5.0	5.0	pH	
Sugar	1.031	1.006	1.013	PO ₂	
Albumin	3+	3+	2+	PCO ₂	
Ketone	Neg	Trace	1+	BE	
WBC	-	2-3	1-2	Bicarb	
RBC	0-1	-	1-2	O ₂ sat.	
Epithelium	0-1	1-2	-		
Bact.	-	-	-		
Cast			3-2		
Blood					
Leukocyte					
Urine prot		14.5			
Urine cret		19.1			
UP/CR					





วันที่ เวลา	25/12/61	26/12/61	26/12/61	27/12/61	27/12/61	28/12/61	29/12/61	29/12/61	29/12/61	29/12/61	30/12/61	30/12/61
PG		264		225		204	304	363	454		230	
BUN	15		11			20	26	36	34	33	31	
Cr	1.10		1.04			0.97	1.27	1.82	0.54	1.40	1.61	
Na	136		135		136	137	146	153	155		160	156
K	4.4		3.7		3.8	3.4	3.6	3.2	3.0		4.3	3.2
Cl	97		96		97	102	106	118	121		128	124
CO ₂	25.5		25.0		20.9	17.5	16.7	13.0	18.2		21.6	16.9
eGFR	73		78			85	61	40	115	55	46	
Ca					8.7							
Po4					2.9							
Mg					1.8							
Cholesterol				218								
TG				149								
HDL-Chol				46								
LDL-Chol		185		165								
HbA1C		9.6						9.1				

วันที่ เวลา	25/12/61	26/12/61	29/12/61	29/12/61	30/12/61							
TP	15.47	22.17	12.15	19.02	05.33							
Alb	4.4		3.4	3.4	3.0							
Glob	3.6		3.2	3.2	3.6							
TB	0.60		1.85	1.69	1.58							
DB	0.23		1.33	0.68	0.99							
SGOT(AST)	36		46	52	40							
SGPT(ALT)	26		34	37	34							
Alkphos	89		72	71	82							
GGT												
PT		11.7										
PTT		24.6										
INR		0.98										

Chest X-ray.....28-12-61: File 0000

EKG.....27-12-61: File 0000

Echo

Plain KUB

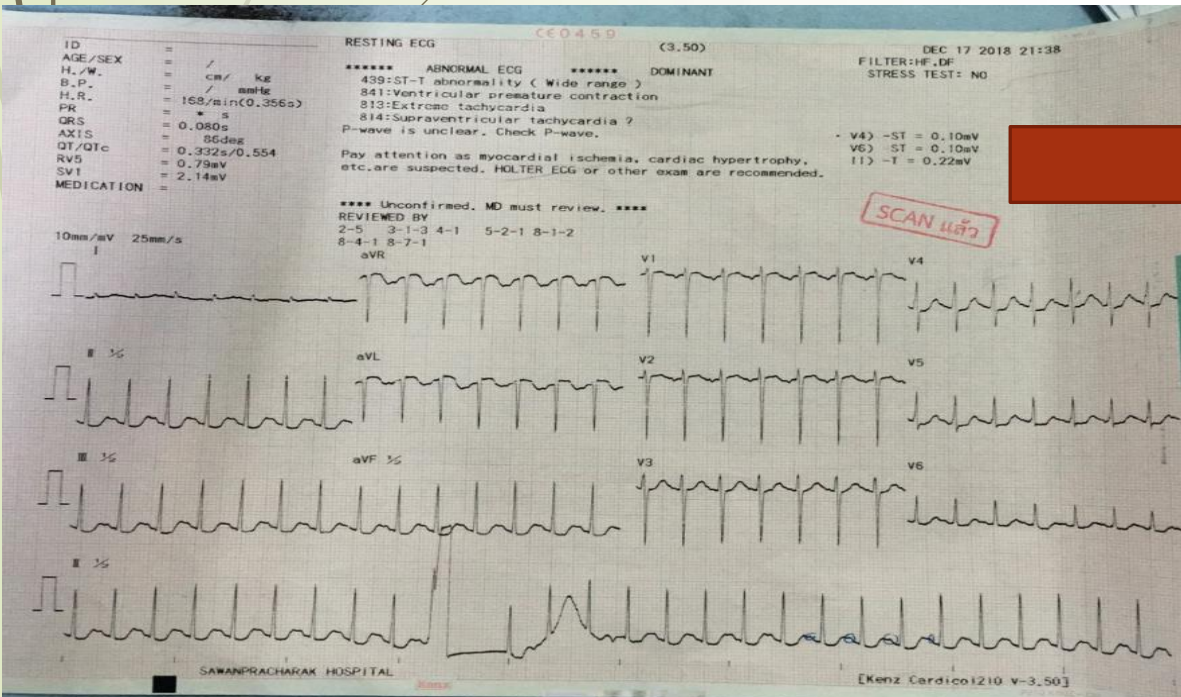
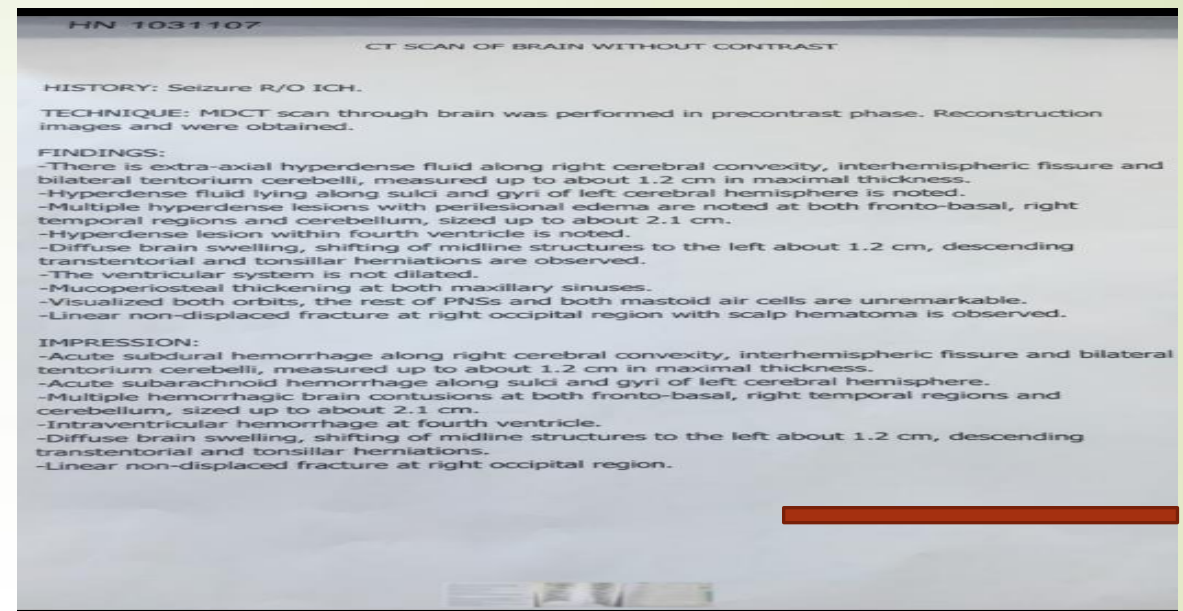
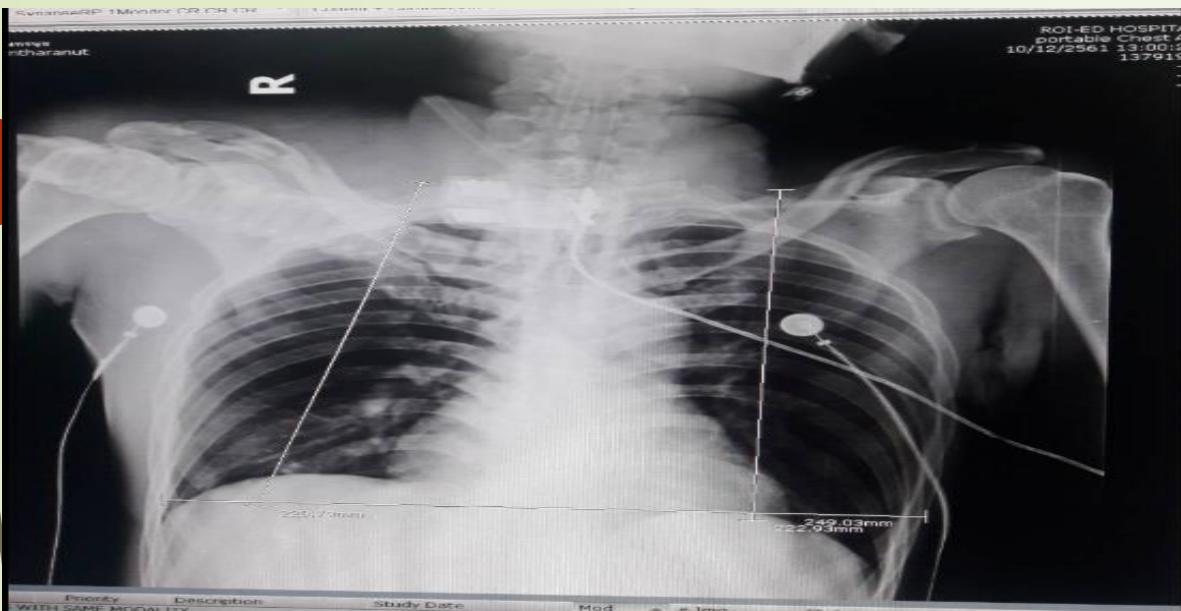
Sputum G/S.....

Sputum c/sไม่มี secretion

Hemo c/s 25-12-61 No growth after 2 days

Urine c/s29-12-61: 50000

Hemo c/s 29-12-61: 50000



โรงพยาบาล [Redacted]
 ใบส่งตรวจและรายงานผลทางห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือด

Name [Redacted] Age 32 ปี H.N. [Redacted]
 AN [Redacted] Ward [Redacted] Clinical diagnosis Cerebella Hemorrhage วันที่ 19/12/2017
 Request by [Redacted] ผู้เจาะเลือด [Redacted] ศร./น.ส.
 (บุตรนาง [Redacted]) (มารดา ด.ช./ด.ญ.)

test	result
☒ ABO grouping	☒ cell group ☒ serum group
☒ Rh[D] Typing	Positive
☐ Direct antiglobulin test	
☐ Indirect antiglobulin test	
☐ Antibody identification	

Reported by [Redacted] Date 19/12/2017

ที่ พิเศษ 824/2562



ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเกิดพระเถรวิมลเสนาบดีพระญาณสังวรฯ
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

24 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขออนุญาตขบวนรถเดินทางไปท่าอากาศยานอุดรธานี

เรียน นายสถานีขอนแก่น

บริษัท ขนส่งการมีนาคมแอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีความจำเป็นต้องเดินทางไปท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อรับบริจาคอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้รอรับอวัยวะเป็นการเร่งด่วน ในกรณีนี้ ขออนุญาตขบวนรถโดยสารเครื่องบิน ออกเดินทางจากขอนแก่นถึงท่าอากาศยานอุดรธานีโดยขบวนรถโดยสารเครื่องบินโดยสาร เที่ยวบินที่ 241/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

1. ขบวนรถโดยสารเครื่องบินที่ 241/2562

1.1 นายแพทย์วิมลเสนาบดี (นายแพทย์วิมลเสนาบดี) Don No. 2716 (ไปเที่ยว)

1.2 นายแพทย์วิมลเสนาบดี (นายแพทย์วิมลเสนาบดี) Don No. 2717 (ไปเที่ยว)

1.3 นายแพทย์วิมลเสนาบดี (นายแพทย์วิมลเสนาบดี) Don No. 2718-2720

1.4 นายแพทย์วิมลเสนาบดี (นายแพทย์วิมลเสนาบดี) Don No. 2719-2721

1.5

1.6

1.7

1.8

2. การเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน 241/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.10 น.

กลับจาก กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน 241/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 17.15 น.

3. ลักษณะที่นำไปคือ

3.1 ลักษณะขบวนรถโดยสารรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 30 x 50 x 30 ซม. จำนวน 3 ใบ

3.2 ลักษณะขบวนรถโดยสารรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 30 x 50 x 30 ซม. จำนวน 3 ใบ

4. ผู้ประสานงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย นายแพทย์วิมลเสนาบดี

โทรศัพท์ 08-1932-8542 08-1932-6957

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์การเดินทางในครั้งนี จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์วิมลเสนาบดี วิมลเสนาบดี)

ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

โทร 1666 หรือ 0 2256 4045-6

โทรสาร 0 2255 7968



NOK AIR

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017



Booking
Confirm:
[17572636](#)
MainPax: KIA
TSIRIKAMON/
SUWANNA
DD9200
20Nov17 05:55
AM Bangkok
(Don Mueang)-
Udon Thani
DD9203
20Nov17 11:55
AM Udon Thani-
Bangkok (Don
Mueang)

*Check-in
Counter Closed
45 Mins Prior to
Departure time

23:08



โรงพยาบาล ราชบุรี.....หอผู้ป่วย ศัลยกรรมระบบประสาท 1...โทร.....

ผู้ประสานงาน คุณ.....24282

จุดนัดหมาย.....ใกล้ถึง รพ.โทรหา.....

ชื่อ-สกุล Donor.....นาย.....อายุ.....47.....ปี Blood Group B+.....

Organ (s) ☒ Liver ☒ Kidney ☒ กระดูก (ทีมกระดูกจัดเก็บ) ☒ ดวงตา (มีทีมจัดเก็บ)

น้ำยา รพ.ศิริราช จัดเตรียมไปเองก่อน ☒ UW 3,000 Bags ☒ Collin's Base...4,000.....Bags

อวัยวะ ที่นำกลับมาศูนย์ฯ

☒ ไต 2 ข้าง

☒ Spleen ทั้งอัน

☒ Lymph nodes ในช่องท้อง

กรุณาเขียนชื่อ Donor และชนิดอวัยวะ

ให้ชัดเจน และผูกติดกับถุงบรรจุอวัยวะ

ตัวอย่างเลือด-เอกสารที่นำกลับมาศูนย์ฯ

☒ Clotted blood 20 cc.

☒ EDTA blood 24 cc.

กรุณา เขียนชื่อ Donor ที่ tube

HARVESTING TEAM REPORT : HTR

☒ Liver ใบแรกสีขาว

☒ Kidney ทั้งชุด 3 แผ่น

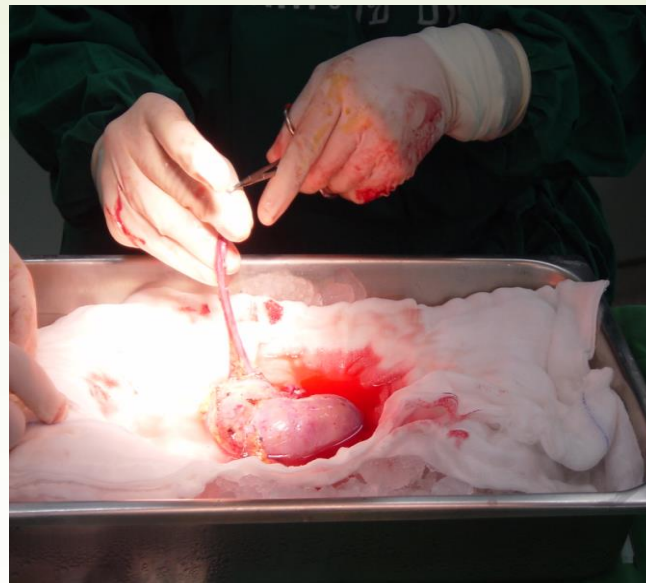
เมื่อนำอวัยวะมาส่งที่ HLA LAB กรุณาติดต่อ จนท.ห้องปฏิบัติการ HLA ชั้น 3 ให้มารับอวัยวะ

โทรศัพท์ (สายภายใน) 1310, 1311, 1302 อยู่ที่โต๊ะ รพก. หน้าห้องจ่ายโลหิต

กรณีสายภายในไม่มีผู้รับ ติดต่อ ..คุณกนกวรรณ...โทร.....089-2273695.....

TC ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โทร. 08 1932 8542ชำนาญ.....

โทร. 08 1933 6957กัลยา.....





Timeline การบริจาคอวัยวะ

ค้นหาและคัดเลือก
ผู้บริจาค



เจรจาขอบริจาคอวัยวะ
และญาติยินยอม

ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

แจ้งศูนย์รับบริจาค
อวัยวะฯ เพื่อจัดสรร

นำส่งศูนย์รับบริจาค
อวัยวะฯ เพื่อการปลูกถ่าย

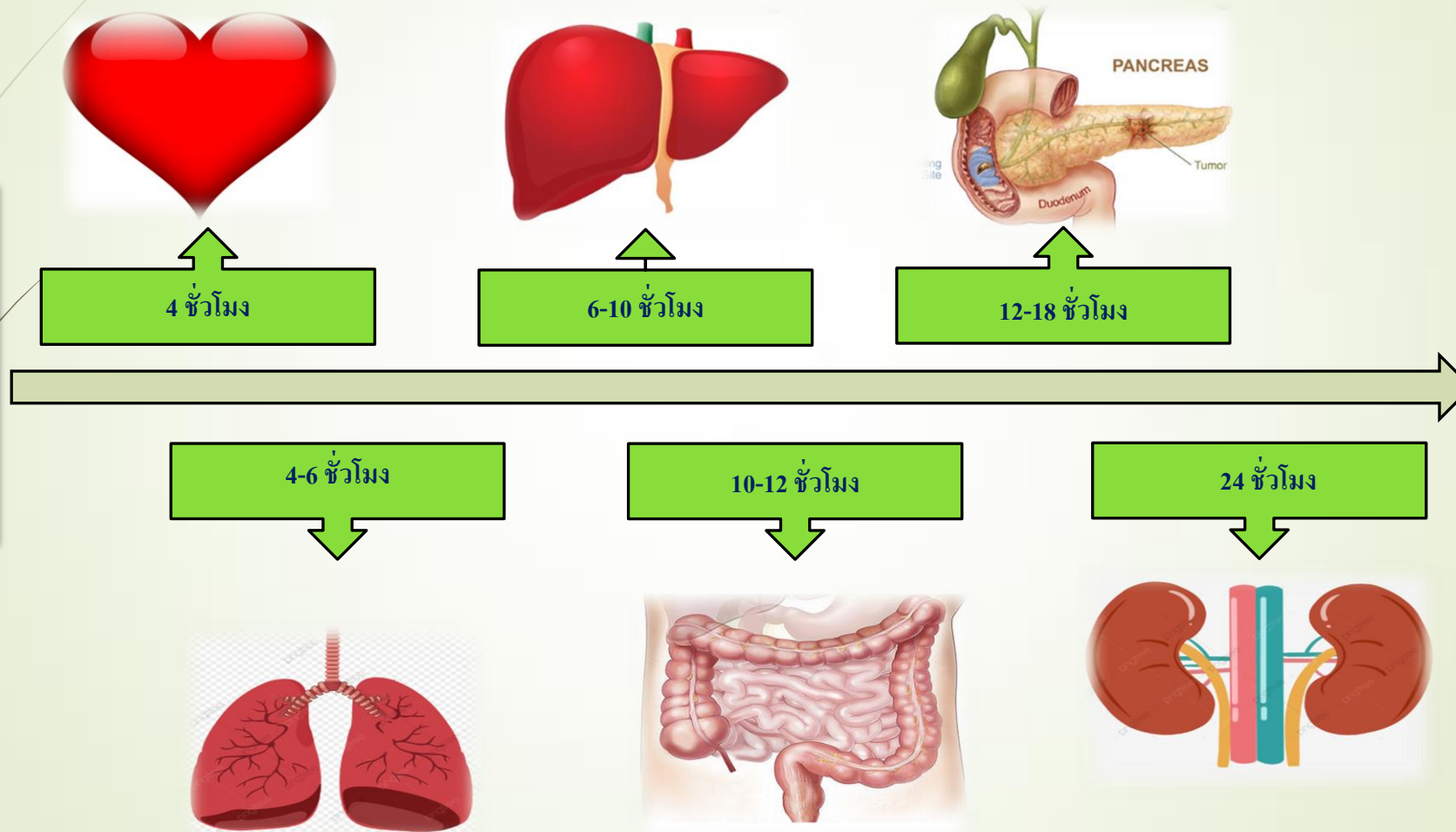
แพทย์วินิจฉัยสมองตาย

ดูแลให้อวัยวะทำงานปกติ

ผ่าตัดนำอวัยวะออก



Timeline การปลูกถ่ายอวัยวะ



Cold Ischemic Time = CIT

บันทึกของทีมผ่าตัดนำอวัยวะออกจากผู้บริจาคสมองตาย
(Harvesting Team Report)

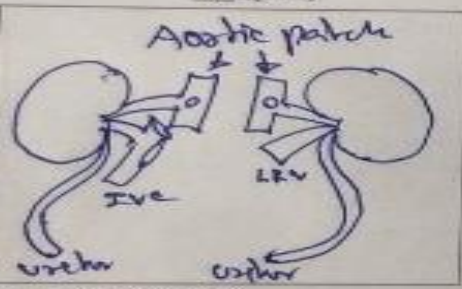
ทีมผ่าตัด 1
ว/ศ/ป 25 4-8 61 โรงพยาบาลที่มีผู้บริจาคอวัยวะ สังกัด H.N. ของผู้บริจาค

ส่วนที่ 1
จากเจ้า [redacted] หัวหน้าทีมผ่าตัดไต
ของโรงพยาบาล [redacted] ได้เป็นบันทึกการตรวจวินิจฉัยของไต
และในยินยอมของญาติผู้บริจาคอวัยวะ [redacted] แล้ว
(ลงชื่อ) [redacted]
ตำแหน่ง [redacted]

ส่วนที่ 2 ทีมแพทย์ 1. พญ. [redacted] โทร. 02- [redacted] 214
2. พญ. [redacted]
3. พญ. [redacted] 4. พญ. [redacted]

เริ่มผ่าตัดเวลา 20:57 น. ทำตัดเส้นเวลา 21:38 น.
Clamp time 20:57 น. Perfusion เริ่มเวลา 21:12 น.

น้ำยา ☒ Euro Collins จำนวน 4000 ml. ☐ UW (Viaspan) จำนวน [redacted] ml.
☐ อื่น ๆ ระบุ [redacted]

1. (รูปวาด)


perfusion	☒ ดี	☐ พอใช้	☐ ไม่ดี
renal a.	R ☒ ปกติ	☐ ติดปกติ ระบุ	☐ ติดปกติ ระบุ
	L ☒ ปกติ	☐ ติดปกติ ระบุ	☐ ติดปกติ ระบุ
2RA จำนวน	1 เส้น	1RA จำนวน	1 เส้น
renal v.	R ☒ ปกติ	☐ ติดปกติ ระบุ	☐ ติดปกติ ระบุ
	L ☒ ปกติ	☐ ติดปกติ ระบุ	☐ ติดปกติ ระบุ
collecting system	R ☒ ปกติ	☐ ติดปกติ ระบุ	☐ ติดปกติ ระบุ
	L ☒ ปกติ	☐ ติดปกติ ระบุ	☐ ติดปกติ ระบุ
ขนาด	☒ ปกติ	☐ ติดปกติ ระบุ	☐ ติดปกติ ระบุ
contusion	R ☒ ไม่มี	☐ มี ระบุ	☐ มี ระบุ
	L ☒ ไม่มี	☐ มี ระบุ	☐ มี ระบุ
hematoma	R ☒ ไม่มี	☐ มี ระบุ	☐ มี ระบุ
	L ☒ ไม่มี	☐ มี ระบุ	☐ มี ระบุ

☐ operative injury (ระบุ)

☐ ผ่าตัดฉีกฉีก iliac a. และ iliac v. มาด้วย
ทว/อภ/ศ

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับผิดชอบ
([redacted]) ตำแหน่ง [redacted] โรงพยาบาล [redacted]

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับผิดชอบ
([redacted]) ตำแหน่ง [redacted] โรงพยาบาล [redacted]

ศิริราช





12:35	CHONG THAM	SI 685	11	12:37	TERMINAL 2	13:40	SI 287	13	13:42	CONFIRMED	13
12:40	SUBAT THAM	DD 2219	15	12:37	TERMINAL 2	13:55	THAM	SI 825	15		15
12:40	EST YAU	DD 7105	12	12:37	TERMINAL 2	13:55	SI 825	15			15
12:50	PHUKET	DD 7203	15	12:50	CONFIRMED	TERMINAL 2	14:00	THAM	DD 7005	11	11
12:50	PHUKET	SI 773	14	12:50	CONFIRMED	TERMINAL 2	14:00	THAM	DD 7400	10	10
12:50	SUBAT THAM	DD 3238	12	13:00	CONFIRMED	TERMINAL 2	14:15	PHU SAKUN OK	DD 3131	9	9
									DD 3205	18	18





อีไร่ 2 ล้อ ช่อมคน-ช่อมรถ-ช่อมถนน-ต่อชีวิต!!
 ปี่แหละ "ตำรวจของพระราช"

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

โรงพยาบาลศิริ

LIVE



โรงพยาบาลศิริราช

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ชูชีพ
โทร. 1669

นำทาง "หัวใจ"

Thai PBS

ภาพ : พล.อ.อ. DBS ชื่นทานนท์ พน. 95.



การดูแลญาติผู้บริจาคอวัยวะ

ข้อมูล

- คำแนะนำเรื่องการบริจาคอวัยวะ

กระบวนการ

- ขั้นตอน, วันที่, เวลา, สถานที่, การตรวจรักษาเพิ่มเติม

แจ้งตาย

- เวชระเบียน, สำนักงานเขตเพื่อออกใบมรณบัตร

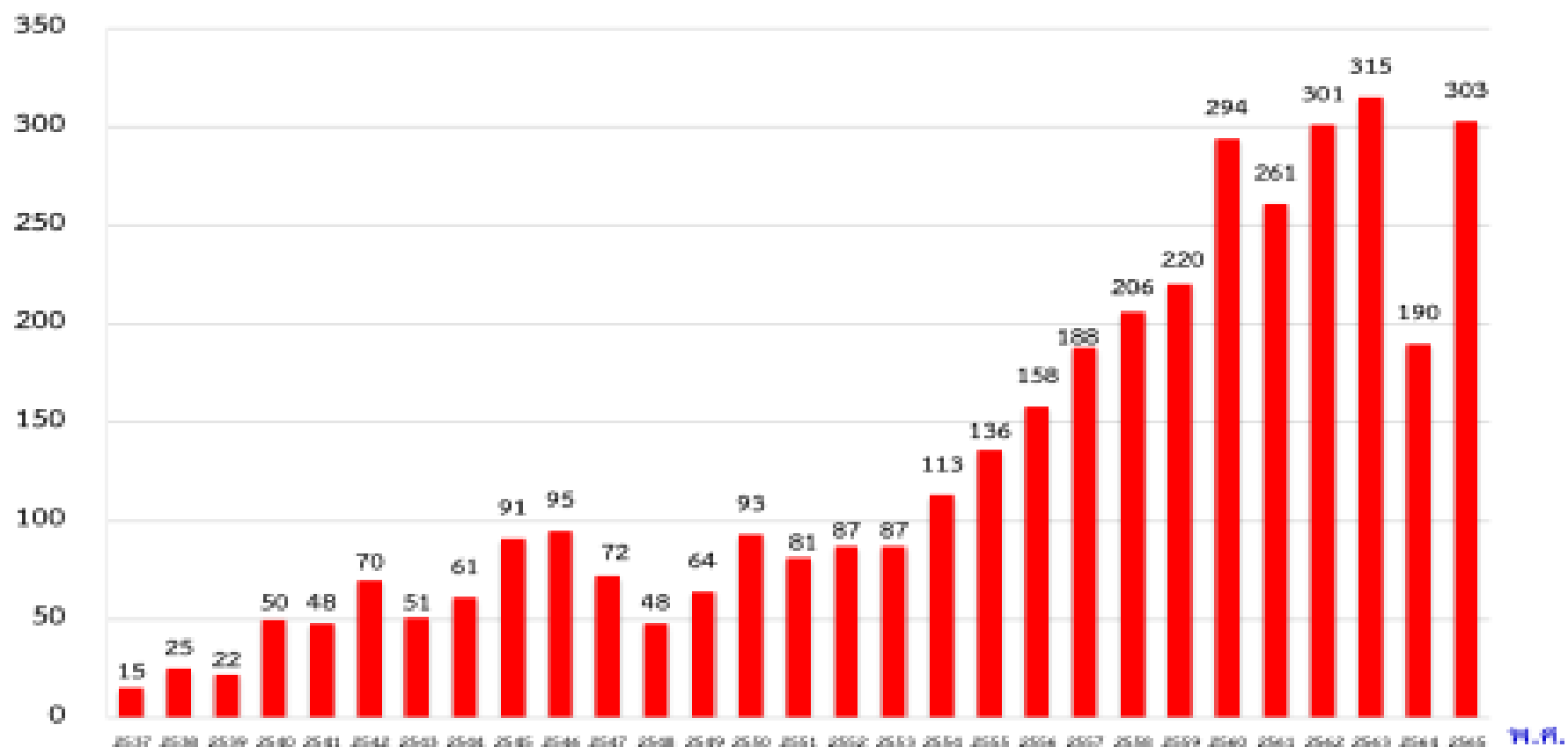
ส่งร่าง

- เอกสาร, ฉีดน้ำยาถนอมศพ, รถรับศพ, วันที่, เวลา,



แผนภูมิแสดงจำนวนผู้บริจาคอวัยวะ (Deceased actual organ donor*) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 - 31 ธันวาคม 2565

จำนวน

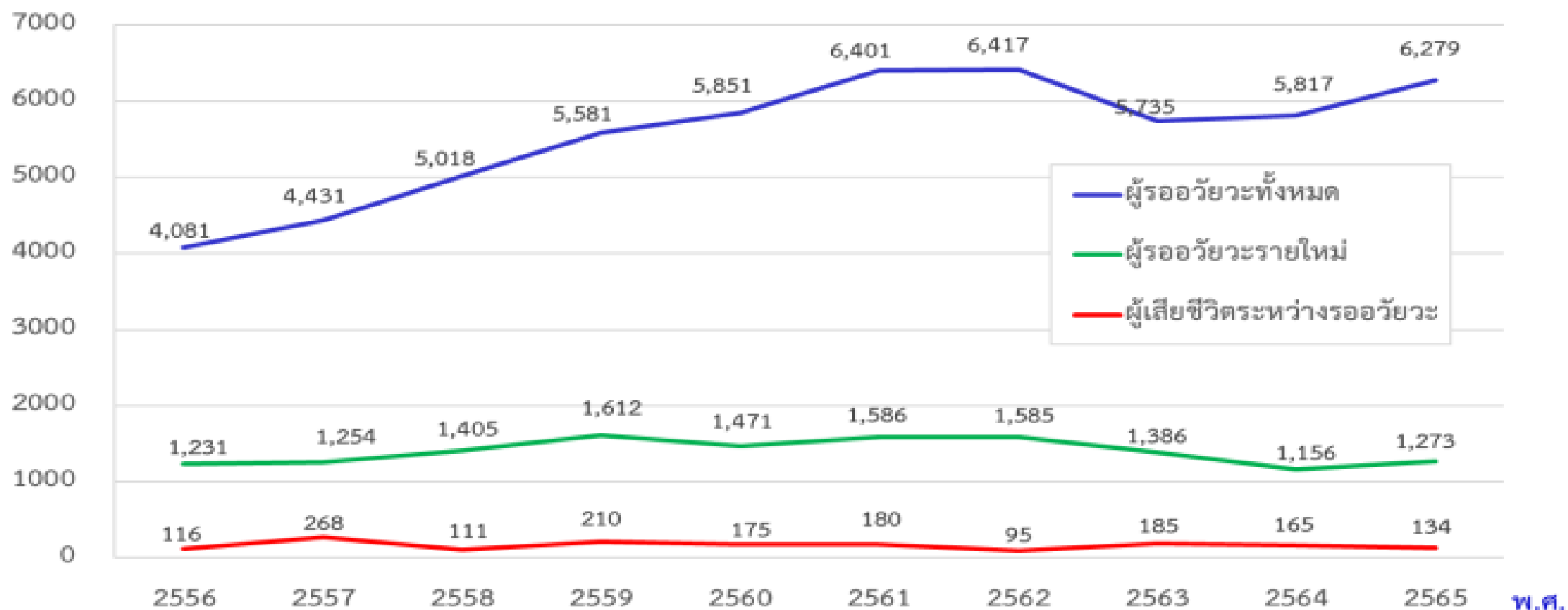


แผนภาพเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้บริจาคอวัยวะ จำแนกตามภาค
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2565



แผนภูมิเปรียบเทียบ ผู้รอวัยวะรายใหม่ ผู้เสียชีวิตระหว่างรอวัยวะ และผู้รอวัยวะทั้งหมด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2565

จำนวน

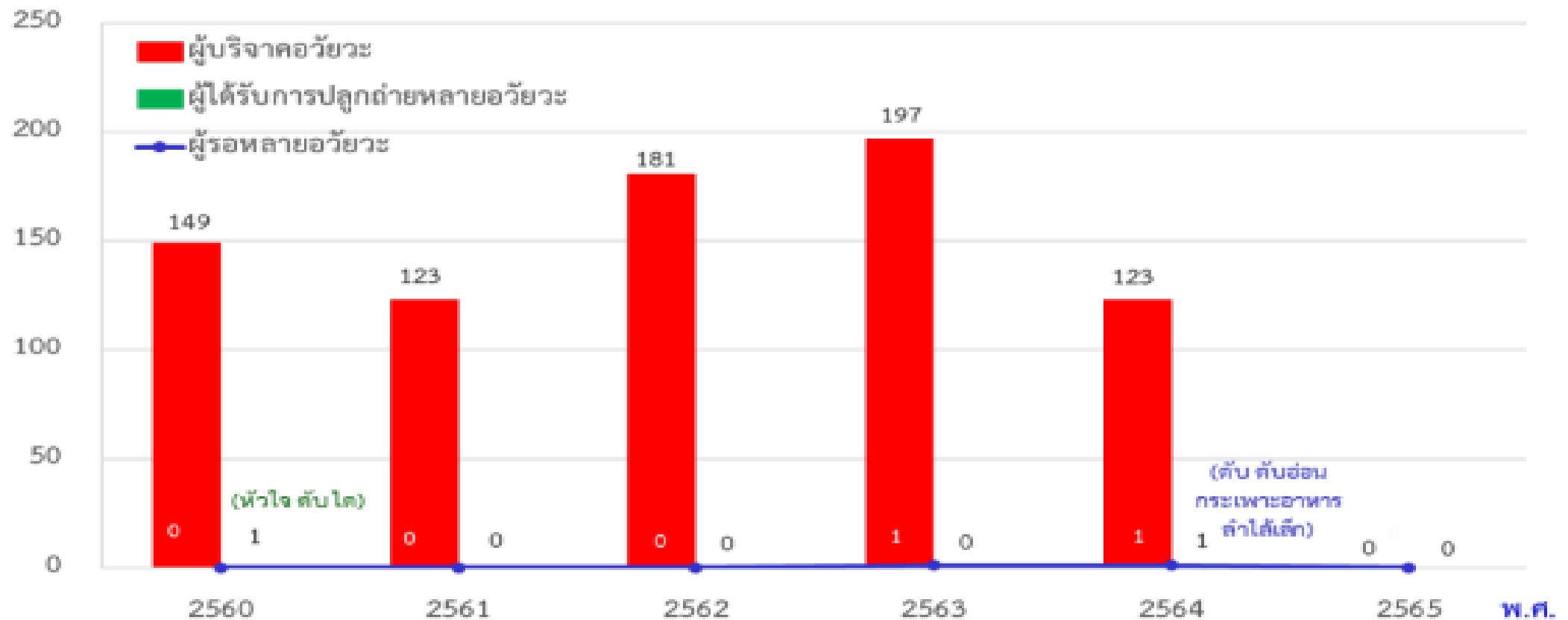


แผนภูมิเปรียบเทียบ

ผู้รอหลายอวัยวะ และผู้ได้รับการปลูกถ่ายหลายอวัยวะ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2565

จำนวน



แสดงระยะเวลารอวีวะของผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต (Waiting Time)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2565



พ.ศ.	ระยะเวลา	ลงทะเบียน			1 st dialysis		
		เฉลี่ย	เร็วที่สุด	นานที่สุด	เฉลี่ย	เร็วที่สุด	นานที่สุด
2561	วัน	945	1	6,015	1,885	82	7,567
	ป-ด-ว	2-7-2	0-0-1	16-5-20	5-1-26	0-2-21	20-8-19
2562	วัน	954	15	6,170	1,877	29	9,310
	ป-ด-ว	2-7-11	0-0-15	16-10-22	5-1-19	0-0-29	25-5-26
2563	วัน	923	4	6,406	1,898	58	11,056
	ป-ด-ว	2-6-11	0-0-4	17-6-15	5-2-12	0-1-27	30-3-8
2564	วัน	889	2	6,326	1730	17	8,426
	ป-ด-ว	2-5-7	0-0-2	17-3-26	4-8-25	0-0-17	23-0-25
2565	วัน	1,075	4	6,619	2,030	31	9,441
	ป-ด-ว	2-11-9	0-0-4	18-1-14	5-6-22	0-1-0	25-10-7

แสดงจำนวนผู้รออวัยวะที่เสียชีวิตระหว่างรออวัยวะ จำแนกตามอวัยวะ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2565



อวัยวะ พ.ศ.	ไต	ตับ	หัวใจ	หัวใจ-ปอด	ปอด	ตับอ่อน	ตับ-ไต	ตับอ่อน-ไต	หัวใจ-ไต	รวม
2556	57	42	7	8	2	-	-	-	-	116
2557	205	48	4	8	1	2	-	-	-	268
2558	60	39	4	2	1	-	5	-	-	111
2559	139	51	10	7	1	-	2	-	-	210
2560	118	35	6	10	4	-	2	-	-	175
2561	138	32	6	3	-	-	1	-	-	180
2562	45	39	10	-	-	-	1	-	-	95
2563	137	30	10	4	2	-	2	-	-	185
2564	117	40	4	3	-	-	1	-	-	165
2565	88	37	7	-	1	-	3	-	-	136
รวม	1,104	393	68	45	12	2	17	-	-	1,641

54 นักกีฬาลุยศึกเปลี่ยนอวัยวะโลก

9 สิงหาคม 2562 - 14:44 น.



ส่งใจเชียร์ทีมชาติไทย ลุยกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ที่ สเปน

© 27 มิ.ย. 60 (10:30 น.) ความคิดเห็น 0



กดฟัง



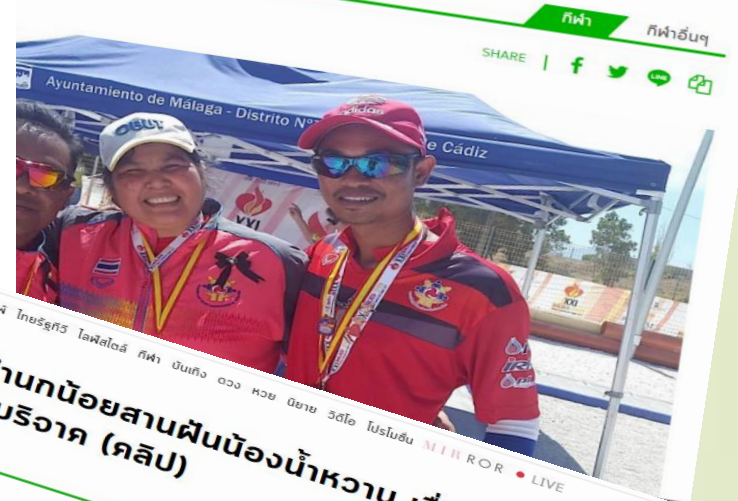
Add @Sanook.com



ทัพนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะชาติไทย ครว้า 12 เหรียญทอง กีฬาโลกที่สเปน

ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี โฟกัสได้ส์ กีฬา บันเทิง ดวง หอข นิยาย วัสดุ โปรมโชน MIRROR • LIVE



ให้ = ต่อชีวิต ป้านกน้อยสานฝันน้องน้ำหวาน เรื่องราวสุดซึ้ง จากผู้รับไตถึงผู้บริจาค (คลิป)

ไทยรัฐออนไลน์

17 มิ.ย. 2561 06:30 น.



THANK YOU



*โทร 1666



ข้อสอบ 4 ข้อ

1. อวัยวะภายในที่สามารถบริจาคเพื่อนำไปปลูกถ่ายมีกี่อวัยวะ

ก. 3 อวัยวะ

ข. 4 อวัยวะ

ค. 5 อวัยวะ

ง. 6 อวัยวะ

2. อวัยวะใดที่ CIT สั้นที่สุด

ก. ปอด

ข. หัวใจ

ค. ตับ

ง. ตับอ่อน

3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องสำหรับการบริจาคอวัยวะ

ก. ประเมินสมองตายก่อนค่อยลงนามบริจาคอวัยวะ

ข. สามารถจัดเก็บอวัยวะเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต

ค. สามารถจัดเก็บอวัยวะเมื่อประเมินสมองตายผ่าน

ง. เมื่อประเมินสมองตายผ่านและหัวใจหยุดเต้น

4. Cold Tschemic Time = CIT หมายถึงข้อใดต่อไปนี้

ก. Clamp Artery Donor ถึง Clamp Artery Recipient

ข. Clamp Artery Donor ถึง Clamp Vein Recipient

ค. Clamp Artery Donor ถึง Reperfusion Recipient

ง. Clamp Vein Donor ถึง Reperfusion Recipient